ILS Wunddrainagen – Information für Lehrkräfte

Ablauf (ca. 90 Minuten): Die SuS lesen einen Abschnitt auf dem Arbeitsblatt (10 Seiten), lösen danach die Übung am Smartphone (QR-Code) und schreiben im Kasten „Examens-Training“ eine Antwort selbst. Zum Schluss folgt das Abschlussquiz.

- Start für die SuS: **klawittersven-arch.github.io/ils-pflege/drainage/** (einmal anmelden: Klasse, Vorname, Geburtstag)
- Übersicht für Sie: **klawittersven-arch.github.io/ils-pflege/lehrkraft/** → ILS-Auftrag „Wunddrainagen“ wählen
- In der Tabelle: ✓ **Datum** = erledigt, ⚠️**2** = zwei Neustarts (zu viele Fehler oder zu schnell getippt – Hinweis auf Raten), ✍️**5/7** = im Examens-Training selbst abgehakte Punkte. „Wer fehlt noch?“ liefert den Text für die PPT.
- Schutz gegen Raten: Aufgaben einzeln, 3 Fehler erlaubt, dann 60 s Lesepause und neue Aufgaben; Mindest-Lesezeit je Aufgabe (3× zu schnell = Neustart); Abschlussquiz (10 aus 25, max. 2 Fehler) erst nach allen Übungen – das prüft auch der Server.

Übungen und Examensbezug

Übung	Inhalte	Aufgabentypen	Examensbezug
1 Wozu Drainagen?	Definition, Nutzen, Nachteile, Einteilung, Redon/Robinson	Sortieren, Bild antippen, Mehrfachauswahl, Lückentext	Nennen, Erklären
2 Beobachten	Kriterien, Kontrollintervalle, Dokumentation, Bilanz aus dem Drainageprotokoll	Zahl aus Protokoll, Ampel-Sortierung, Richtig/Falsch mit Begründung	Pool Tag 3: „Nennen Sie (x) Beobachtungskriterien …“
3 Komplikationen	Nachblutung, Schock (Früh-/Spätphase), Sofortmaßnahmen, SBAR, Infektion, Hämatom	Fallentscheidung mit Verzweigung, Reihenfolge (SBAR), Sortieren	Tag 3 / CE 06: Anzeichen + Sofortmaßnahmen
4 Umgang, Hygiene, Recht	Information/Mobilisation, Flaschenwechsel, Robinson leeren, WHO-Händehygiene, Delegation, Remonstration	Reihenfolge, Bild antippen, Gesprächssimulation, Sortieren	„Ablauf in (x) Schritten“, Delegation (6 von 7 Tag-3-Prüfungen)
5 Pflegeprozess	PESR, überprüfbare Ziele, konkrete Interventionen	PESR-Sortierung, Ziel-Check, Reihenfolge	PESR/Ziele/ Interventionen in jeder Prüfung
Abschluss	Transfer auf neuen Fall (Robinson nach Gallen-OP)	gemischt, 10 aus 25	–

Erwartungshorizonte Examens-Training

1. Nennen Sie 3 Ziele (Nutzen) einer Wunddrainage und 2 mögliche Nachteile.

- Ziel: Hämatombildung verhindern
- Ziel: Infektionsrisiko senken
- Ziel: Nahtdehiszenz vorbeugen / Wundflächen legen sich aneinander
- Nachteil: Eintrittspforte für Erreger (aufsteigende Infektion)
- Nachteil: Gewebeschädigung durch das Schlauchende, Hautmazeration (offene Drainage) oder Angst vor der Mobilisation

2. Beschreiben Sie 4 Beobachtungskriterien bei Frau Kramers Redon-Drainage und **begründen** Sie jeweils kurz, warum Sie darauf achten.

- Fördermenge (regelmäßig ablesen) – um eine Nachblutung früh zu erkennen
- Aussehen des Sekrets (Farbe, Konsistenz, Geruch) – Hinweis auf Blutung oder Infektion
- Vakuumindikator – ob noch genug Sog vorhanden ist
- Durchgängigkeit, kein Knick – sonst Förderstau und Hämatom

- Austrittsstelle, Verband und Fixierung – Infektion, Nachblutung, Herausrutschen
- Zustand von Frau Kramer (Schmerzen, Puls, Blutdruck, Hautfarbe) – Schockzeichen erkennen
- Jede Beobachtung mit einer Begründung (Fallbezug: Hüft-TEP, Enoxaparin)

3. Beschreiben Sie 4 Anzeichen, an denen Sie bei Frau Kramer eine Nachblutung mit beginnendem Schock erkennen, und 4 Sofortmaßnahmen.

- Anzeichen: plötzlich viel und hellrotes (frisch-blutiges) Sekret in der Redon
- Anzeichen: durchgebluteter Verband, Schwellung im Wundgebiet
- Anzeichen: Puls schnell (über 100/min), Blutdruck zunächst normal, dann fallend
- Anzeichen: Haut blass, kühl, feucht; Unruhe oder Angst
- Maßnahme: Hilfe holen, Ärztin sofort informieren – nicht allein lassen
- Maßnahme: Vitalzeichen engmaschig messen
- Maßnahme: Schocklagerung nach Absprache, Wärme erhalten, beruhigen
- Maßnahme: Drainage nicht abklemmen; danach dokumentieren

4. Beschreiben Sie in 6 Schritten den Wechsel einer Redonflasche.

- Patientin informieren (kurzer Schmerz durch den Sog möglich)
- Hände desinfizieren, Einmalhandschuhe anziehen
- erst die patientennahe, dann die patientenferne Klemme schließen
- Ableitung lösen, Ansatzstück sprühdesinfizieren
- neue Flasche mit sichtbarem Sog anschließen
- erst die patientennahe, dann die patientenferne Klemme öffnen, Sog prüfen
- Fördermenge der alten Flasche und Wechsel dokumentieren

5. Formulieren Sie für Frau Kramer das Pflegeproblem „Angst vor der Mobilisation“ nach dem PESR-Schema und **ein** überprüfbares Pflegeziel.

- P: Angst vor der Mobilisation (fachlich korrekt benannt)
- E: z. B. fürchtet, die Drainage herauszureißen; nicht informiert; 1. Tag nach Hüft-TEP
- S: z. B. bewegt sich kaum, fragt nach dem Schlauch, äußert Angst
- R: z. B. motiviert, wach und orientiert, möchte mit der Physiotherapie gehen
- Ziel nennt einen beobachtbaren Zustand (z. B. „geht mit Begleitung zum Waschbecken“)
- Ziel hat einen Zeitpunkt (z. B. „bis morgen Mittag“)

Fachliche Grundlage und Ergänzungen

Grundlage ist **Pflegias** (Cornelsen): Band 1 S. 643–648 (Überwachung nach einem Eingriff, Umgang mit Wunddrainagen), S. 684–686 (Verbandwechsel), S. 691 (Hämatom); Band 2 S. 359 (Pflege nach OP am Bewegungsapparat), S. 418, 801, 811 (Schock). Begriffe, Zahlen und die Reihenfolge des Flaschenwechsels sind daraus übernommen.

Diese Punkte stehen so nicht in Pflegias (Standardwissen) – bitte mit Ihrem Hausstandard abgleichen:

- Zuordnung **Robinson = Schwerkraft**, **Easy-Flow = Kapillarwirkung** (Pflegias nennt nur „passiv: Schwerkraft oder Kapillarwirkung“).
- Robinson-Beutel **immer unter Wundniveau** (Rückfluss) und **Leeren über den Ablaufstutzen** als Ablauf.
- **Grünlich-braunes (galliges) Sekret** in der Robinson → Ärztin informieren.
- **Meldegrenzen** (z. B. mehr als 100 ml in 1 Stunde) stehen bewusst in der fiktiven ärztlichen Anordnung des Falls – Pflegias nennt keine Richtwerte.
- Der Begriff **Nachblutung** (in Pflegias Band 1 ohne eigenen Abschnitt); Schockzeichen und Sofortmaßnahmen sind aus Band 2.
- Bei Schockverdacht **nüchtern lassen**, bis die Ärztin entschieden hat.
- Vakuumindikator nach Wechsel **sofort wieder entfaltet** → Leck oder verrutschte Drainage.
- **Herausgerutschte Drainage:** steril abdecken, Ärztin informieren, Drainage zur Kontrolle aufbewahren, nicht wieder einführen.
- **Händedesinfektion** beim Flaschenwechsel (Pflegias nennt Handschuhe und Sprühdesinfektion des Ansatzstücks).

- **Beobachtung und Dokumentation nach dem Entfernen**; ob mit oder ohne Sog gezogen wird → laut AB „Standard Ihres Hauses“.
- **Delegation des Ziehens** wird als „in manchen Häusern“ thematisiert – laut Pflegias entfernt der Arzt die Redon.

Klassenliste, Fortschritt und Passwort verwalten Sie auf der Lehrkraft-Seite (Verwaltung). Gelöscht wird nur von Hand.